

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

ESCALA DE TEPT ADMINISTRADA POR EL CLÍNICO (CAPS-5)

Clinician-Administered PTSD Scale for DSM-5 (Weathers et al., 2013, 2018) · National Center for PTSD

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL Y FICHA RESUMEN

Nombre oficial	Escala para el Trastorno de Estrés Postraumático Administrada por el Clínico para DSM-5 (CAPS-5)
Sigla / Acrónimo	CAPS-5 (evolución del CAPS-1 y CAPS-2 para DSM-IV)
Autoría original	Frank W. Weathers, D. D. Blake, P. P. Schnurr, D. G. Kaloupek, B. P. Marx & T. M. Keane (2013, 2018)
Titular institucional	National Center for PTSD, U.S. Department of Veterans Affairs (VA)
Constructo evaluado	Presencia diagnóstica categorial y gravedad dimensional continua de los síntomas de TEPT según DSM-5
Población diana	Adultos y veteranos expuestos a acontecimientos traumáticos graves (combate, agresiones, desastres)
Tiempo de aplicación	45 a 60 minutos (entrevista clínica estructurada integral conducida por profesional cualificado)
Estructura y formato	30 ítems semiestructurados: criterios A a G del DSM-5 más especificación del subtipo disociativo
Condiciones de uso	Propiedad del National Center for PTSD; disponible gratuitamente previa solicitud oficial y registro

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

La CAPS es universalmente reconocida como el "patrón oro" (**gold standard**) clínico para la evaluación y el diagnóstico del Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT). Fue concebida por el equipo del Centro Nacional de TEPT de EE.UU. para superar las discrepancias diagnósticas entre distintos evaluadores y eliminar los sesgos propios de los autoinformes retrospectivos no supervisados.

El marco conceptual de la versión CAPS-5 refleja fielmente la reformulación nosológica del DSM-5, la cual trasladó el TEPT de los trastornos de ansiedad a la nueva categoría de **Trastornos Relacionados con Traumas y Factores de Estrés**. La entrevista operacionaliza el modelo de cuatro factores sintomáticos: 1) Intrusión / Reexperimentación; 2) Evitación activa; 3) Alteraciones cognitivas y del estado de ánimo negativas persistentes; y 4) Hiperactivación autonómica y reactividad psicomotora, además de evaluar el inicio diferido y la disociación (despersonalización/desrealización).

3. ESTRUCTURA Y AGRUPAMIENTO POR CRITERIOS DSM-5

Criterio DSM-5	Ítems Origen	Rango	Manifestaciones Clínicas Exploradas
Criterio A: Suceso	Ítem A	Cualitativo	Identificación del trauma índice: exposición a muerte real o amenaza, lesiones o violencia sexual
Criterio B: Intrusión	Ítems B1 a B5	0 - 20	Recuerdos angustiosos, pesadillas, flashbacks disociativos, malestar ante estímulos y reactividad física
Criterio C: Evitación	Ítems C1 y C2	0 - 8	Evitación de recuerdos/pensamientos internos y evitación de recordatorios o lugares externos
Criterio D: Cognición/Ánimo	Ítems D1 a D7	0 - 28	Amnesia disociativa, creencias negativas globales, autculpa, emociones negativas, anhedonia y desapego
Criterio E: Reactividad	Ítems E1 a E6	0 - 24	Irritabilidad/ira, hipervigilancia, sobresalto exagerado, concentración deficiente, insomnio y conductas temerarias
Criterios F, G y Subtipo	Ítems F, G, Disoc.	0 a 4 / ítem	Duración > 1 mes (F), malestar funcional significativo (G) y despersonalización/desrealización

EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA, BAREMACIÓN Y CÓMPUTO CLÍNICO

4. PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS COMO ESTÁNDAR DE REFERENCIA

Consistencia interna	Excelente fiabilidad psicométrica; alfa de Cronbach global $\alpha = 0.88 - 0.94$; subescalas: Intrusión $\alpha = 0.85$, Evitación $\alpha = 0.80$, Cognición/Ánimo $\alpha = 0.87$, Hiperactivación $\alpha = 0.84$ (Weathers et al., 2018).
Fiabilidad interobservador	Concordancia prácticamente perfecta entre examinadores cualificados; coeficiente de correlación intraclase CCI = $0.91 - 0.98$; índice Kappa diagnóstica $\kappa = 0.83 - 0.89$.
Validez convergente	Correlación muy alta con el autoinforme PCL-5 ($r = 0.83 - 0.87$) y con la escala de trauma IES-R ($r = 0.78$).
Validez discriminante	Diferencia con gran especificidad los síntomas postraumáticos de los trastornos depresivos mayores puros y de la ansiedad generalizada ($p < 0.001$).
Sensibilidad al cambio	Capacidad óptima para medir el impacto de tratamientos basados en la evidencia (EMDR, Terapia de Exposición Prolongada y Terapia de Procesamiento Cognitivo).

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO DE PUNTUACIONES

Métrica de severidad unificada	A diferencia del CAPS anterior (que puntuaba frecuencia e intensidad por separado), el CAPS-5 combina ambas en una escala ordinal única de severidad de 0 a 4 : 0 = Ausente ; 1 = Leve ; 2 = Moderado ; 3 = Grave ; 4 = Extremo .
Regla diagnóstica por síntoma	Un síntoma se considera clínicamente presente si obtiene una puntuación de gravedad ≥ 2 (Moderado).
Criterio diagnóstico DSM-5	Para el diagnóstico de TEPT se requiere: Criterio A cumplido + al menos 1 síntoma de B (≥ 2) + al menos 1 síntoma de C (≥ 2) + al menos 2 síntomas de D (≥ 2) + al menos 2 síntomas de E (≥ 2) + Criterio F (duración > 1 mes) + Criterio G (malestar o interferencia).
Puntuación continua de gravedad	Suma aritmética directa de los 20 ítems de los criterios B a E: rango teórico de 0 a 80 puntos .

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Puntuación (0-80)	Percentil Aprox.	Gravedad del TEPT	Implicación Asistencial y Discapacidad
0 - 12 puntos	$< Pc\ 40$	Subclínico / Remisión	Sintomatología traumática mínima o resuelta; buen funcionamiento.
13 - 25 puntos	$Pc\ 45 - Pc\ 65$	TEPT Leve / Incipiente	Cumple criterios límite; interferencia en situaciones específicas.
26 - 45 puntos	$Pc\ 70 - Pc\ 85$	TEPT Moderado	Diagnóstico clínico formal; pesadillas y evitación activa limitantes.
46 - 80 puntos	$> Pc\ 85$	TEPT Grave / Incapacitante	Parálisis social, hipervigilancia extrema, riesgo de descompensación disociativa.

PUNTOS DE CORTE Y REGLA DE REMISIÓN CLÍNICA:

- **Puntuación de Gravedad ≥ 26 :** Punto de corte habitualmente utilizado en ensayos clínicos para definir TEPT clínicamente significativo y con afectación de la calidad de vida.
- **Criterio de Pérdida del Diagnóstico:** Reducción de la gravedad por debajo del umbral categorial del DSM-5 o descenso de ≥ 15 puntos respecto a la línea base tras psicoterapia de trauma.

DECISIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO, SEGURIDAD Y BIBLIOGRAFÍA

7. ALGORITMO DE INTERVENCIÓN BASADO EN EL TRAUMA

Paso 1: Administración de la entrevista CAPS-5: Establecer el trauma índice principal y evaluar los 20 síntomas.

Paso 2: Si Cumple Criterios Diagnósticos de TEPT:

- Evaluar presencia de **Subtipo Disociativo** (despersonalización/desrealización). Si es positivo, iniciar con fases preparatorias de estabilización y anclaje sensorial (**grounding**) antes de la exposición.
- Tratamiento psicoterapéutico de primera elección: Terapia focalizada en el trauma (EMDR o Exposición Prolongada de Foa).
- Fármacos autorizados si coexiste severo malestar afectivo o insomnio: Sertralina o Paroxetina; considerar Prazosina para pesadillas traumáticas refractarias.

Paso 3: Si Hay TEPT Subumbral (13 — 25 puntos): Apoyo psicológico focalizado para prevenir la consolidación crónica del cuadro tras accidentes o agresiones recientes.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO EN UNIDAD DE TRAUMA

Identificación: Mujer de 33 años, conductora de ambulancia, atendida 6 meses después de sufrir un accidente de tráfico grave durante un servicio de urgencia en el que falleció su compañero. Presenta bajas laborales continuadas, pesadillas y taquicardias ante ruidos de sirenas.

Evaluación CAPS-5 Inicial: Puntuación Total de Gravedad = **52 / 80** (TEPT Grave).

- Criterio B (Intrusión): 14/20 (pesadillas casi diarias = 3, recuerdos intrusivos = 4, reactividad fisiológica = 4).
- Criterio C (Evitación): 7/8 (evita conducir y circular por la autovía del siniestro).
- Criterio D (Cognición): 18/28 (culpa recurrente por haber sobrevivido, anestesia afectiva con su familia).
- Criterio E (Hiperactivación): 13/24 (sobresalto extremo ante bocinas, hipervigilancia constante al tráfico).

Diagnóstico Formal: Cumple criterios completos de TEPT crónico grave sin subtipo disociativo.

Intervención: Tratamiento con EMDR (Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares) de 14 sesiones, procesando las dianas mnésicas del impacto y la culpa del superviviente.

Reevaluación a los 4 meses: La gravedad en el CAPS-5 descendió a **12 / 80** (Subclínico, pérdida total del diagnóstico formal de TEPT, reducción de 40 puntos); la paciente reanudó la conducción de vehículos particulares sin crisis de angustia.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Banderas Rojas y Riesgo Vital:

- **Riesgo de Suicidio en TEPT:** La combinación de flashbacks incontrolables, insomnio y culpa mórbida dispara el riesgo de suicidio impulsivo.
- **Re-traumatización latrogénica:** Evitar técnicas de exposición inundativa sin estabilización previa en pacientes disociativos o lábiles.

Diagnóstico Diferencial:

- **TEPT vs. Trastorno de Estrés Agudo:** Si los síntomas duran entre 3 días y 1 mes es estrés agudo; para TEPT se requiere duración > 1 mes.
- **Trastorno de Adaptación:** El estresor vital no reúne la gravedad del Criterio A (muerte o amenaza a la integridad física).

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (FORMATO APA 7ª ED.)

- Weathers, F. W., Bovin, M. J., Lee, D. J., Sloan, D. M., Schnurr, P. P., Kaloupek, D. G., Keane, T. M., & Marx, B. P. (2018). The Clinician-Administered PTSD Scale for DSM-5 (CAPS-5): Development and initial psychometric evaluation in military veterans. *Psychological Assessment*, 30(3), 383-395. <https://doi.org/10.1037/pas0000486>
- Blake, D. D., Weathers, F. W., Nagy, L. M., Kaloupek, D. G., Gusman, F. D., Charney, D. S., & Keane, T. M. (1995). The development of a Clinician-Administered PTSD Scale. *Journal of Traumatic Stress*, 8(1), 75-90.
- National Center for PTSD. (2013). *The Clinician-Administered PTSD Scale for DSM-5 (CAPS-5) - Past Month Version*. U.S. Department of Veterans Affairs.
- Foa, E. B., Keane, T. M., Friedman, M. J., & Cohen, J. A. (Eds.). (2008). *Effective treatments for PTSD: Practice guidelines from the International Society for Traumatic Stress Studies*. Guilford Press.